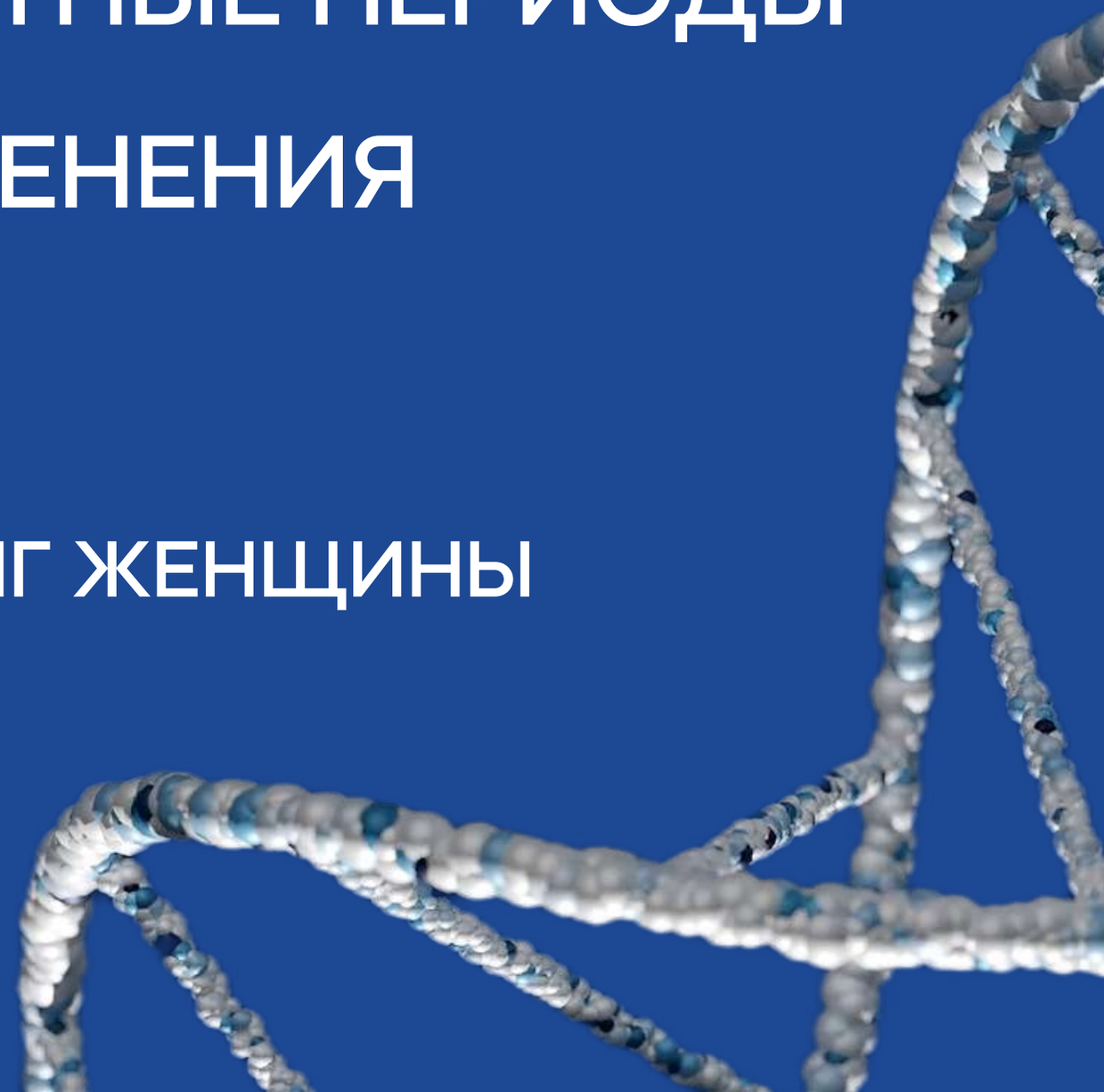
Сеченовский Университет

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЖЕНСКОЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ КОРРЕКЦИЯ

МЕНОПАУЗА И ЭЙДЖИНГ ЖЕНЩИНЫ

Доцент И.А. Куликов, к.м.н.



Цель занятия

Составить представление о времени начала и мерах коррекции здоровья женщины

План занятия

1. Менопауза
2. Антивозрастная терапия. Медикаментозное направление
3. Улучшение качества жизни
4. Эстетическая медицина

Сеченовский Университет

МЕНОПАУЗА

STRAW+10

Этапы репродуктивного старения женщин

— клинико-гормональная характеристика этапов старения репродуктивной системы (Stages of Reproductive Aging Workshop — STRAW) разработаны в **2001 г.** и пересмотрены в **2011 г.** с учётом результатов крупных когортных исследований, проведённых в течение последующих 10 лет (STRAW+10)

Определение и этапы

Менопауза — последняя самостоятельная менструация и является ретроспективным клиническим диагнозом, устанавливается после 12 последовательных месяцев отсутствия менструаций (аменореи)

Этапы

1. Период менопаузального перехода
2. Менопауза
3. Перименопауза
4. Постменопауза

Патогенез

«Выключение» функции яичников приводит к состоянию гипергонадотропного гипогонадизма и характеризуется:

- изменением функции лимбической системы
- нарушением секреции нейрогормонов
- развитием инволютивных и атрофических процессов в репродуктивных и нерепродуктивных органах-мишенях

Когда начинать подготовку к эйджингу

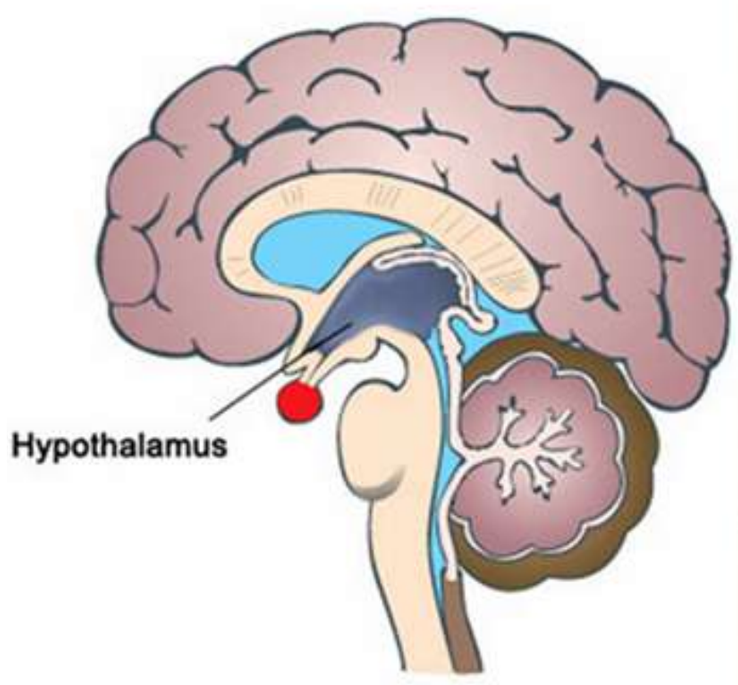
- Пропущенные циклы, эпизоды аменореи и повышенная частота ановуляторных циклов длится в течение 1–3 лет, предшествующих наступлению последнего менструального цикла (ПМЦ)

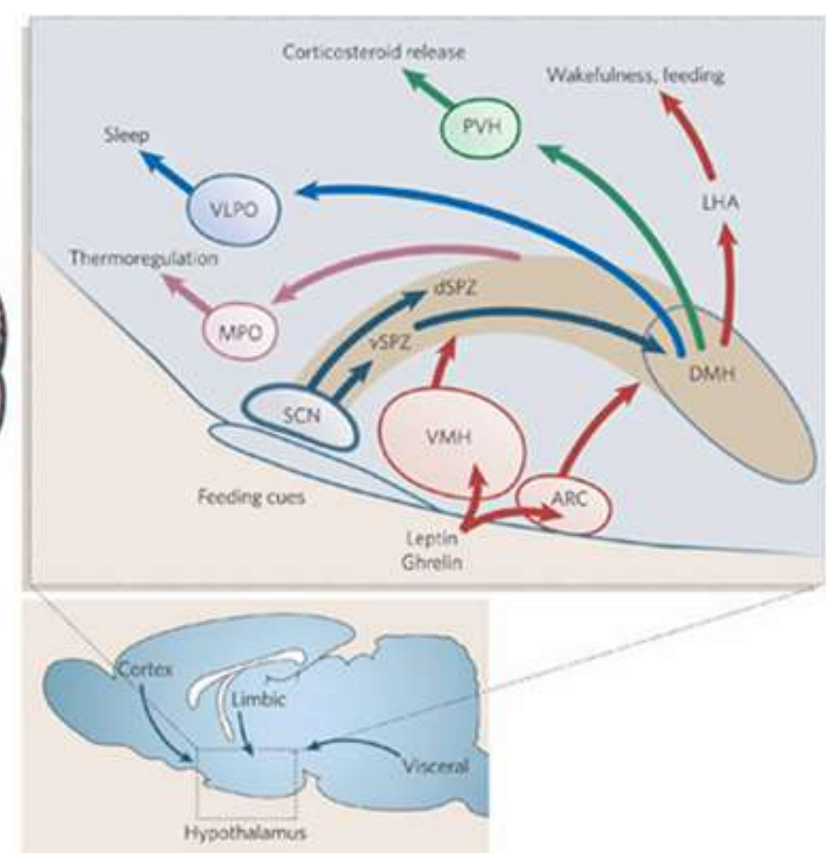
- Сопровождается постепенным повышением уровня ФСГ и снижением уровня эстрогенов

Патогенез симптомов

В патогенезе основная роль принадлежит рассогласованию деятельности гипоталамических структур головного мозга, обеспечивающих координацию кардиоваскулярных, респираторных и температурных реакций с эмоционально-поведенческими

При климактерическом синдроме проявляются имевшиеся ранее нарушения в высших регуляторных центрах





Ранние симптомы

Вазомоторные

- Приливы
- Повышенная потливость

Психологические

- Депрессивные симптомы
- Раздражительность
- Возбудимость
- Расстройство сна
- Слабость
- Сниженная память и концентрация внимания

Общие физические

- Астенизация
- Головные боли
- Мышечносуставные боли
- «Ползание» мурашек на коже

Урогенитальные и сексуальные

- Зуд
- Жжение
- Сухость
- Диспареуния
- Нарушение мочеиспускания (ургентное, частое)

Около 75% женщин в возрасте 45–55 лет предъявляют жалобы на приливы, в 28,5% случаев — средней или тяжёлой степени выраженности

Средняя продолжительность приливов составляет 7,4 года, однако в последнее время у значительного числа женщин они могут продолжаться ≥10 лет

Сеченовский Университет

АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

Медикаментозная терапия

1. Препараты МГТ (Системная (пероральные, инъекционные, трансдермальные) и/или Местная (свечи и мази))
2. Снижение массы тела
3. Когнитивно-поведенческая терапия
4. Клинический гипноз
5. Акупунктура
6. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН)
7. Полипептиды эпифиза (шишковидной железы) крупного рогатого скота
8. Лекарственные препараты (экстракт) корневищ цимицифуги кистевидной
9. Препараты бета-аланина
10. Негормональные любриканты

Соотношение не в пользу назначения МГТ?

Назначение МГТ

- Согласно российским и международным рекомендациям, **менопаузальная гормональная терапия (МГТ)** — самый эффективный метод лечения климактерических расстройств и предупреждения заболеваний, связанных с возрастным дефицитом эстрогенов у женщин

- В европейских странах препараты МГТ принимают 37% женщин старше 50 лет, в США — 25%, странах Латинской Америки — 12,5%, Японии — 4%, России — 2,8%

- Более трети женщин (35,6%), имеющих показания к назначению МГТ, боятся риска спровоцированной «онкологии»

- 47,5% врачей связывают с МГТ увеличение онкологических рисков

Показания для назначения МГТ

- Вазомоторные симптомы с изменением настроения, нарушением сна
- Симптомы генитоуринарного синдрома, сексуальная дисфункция
- Профилактика и лечение остеопороза
- Низкое качество жизни, связанное с климактерием, включая артралгии, мышечные боли, снижение памяти
- Преждевременная и ранняя менопауза
- Двусторонняя овариэктомия

Не рекомендуется

назначать МГТ при отсутствии чёткого показания для её применения, т.е. значимых симптомов или физических последствий дефицита эстрогенов

Принципы назначения МГТ

- «Временная» гипотеза начинала МГТ — в возрасте моложе 60 лет, при длительности постменопаузы менее 10 лет

- Схема назначения — Монотерапия эстрогенами (женщинам с удалённой маткой) или Комбинированная терапия (эстрогены с прогестагенами)

- Средняя продолжительность приёма комбинированной гормонотерапии составляет 5 лет, монотерапии эстрогенами — 7 лет

Режимы назначения МГТ

1. Монотерапия эстрогенами (женщинам с удалённой маткой)

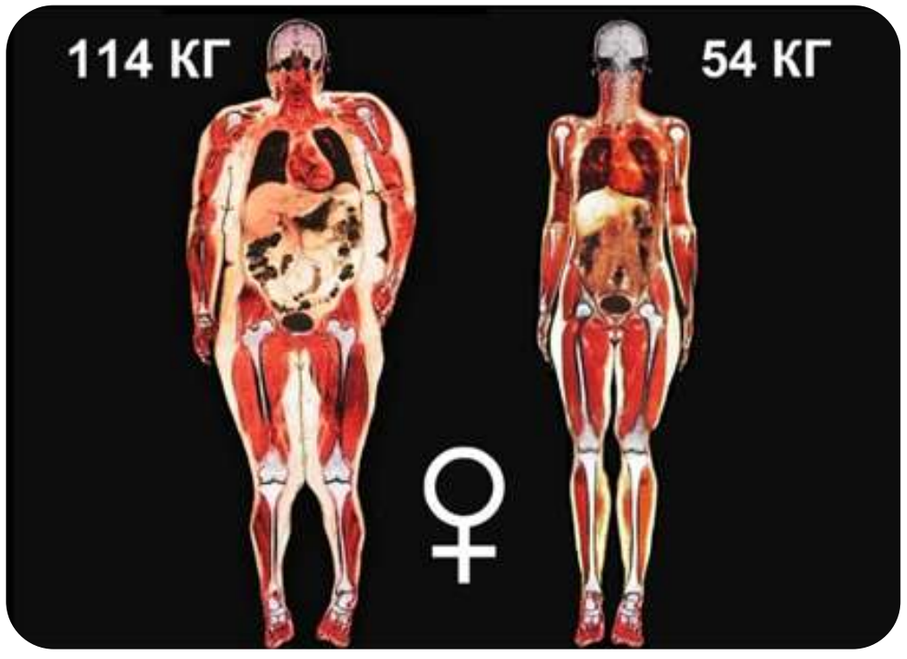
2. Комбинированная терапия (эстрогены с прогестагенами)

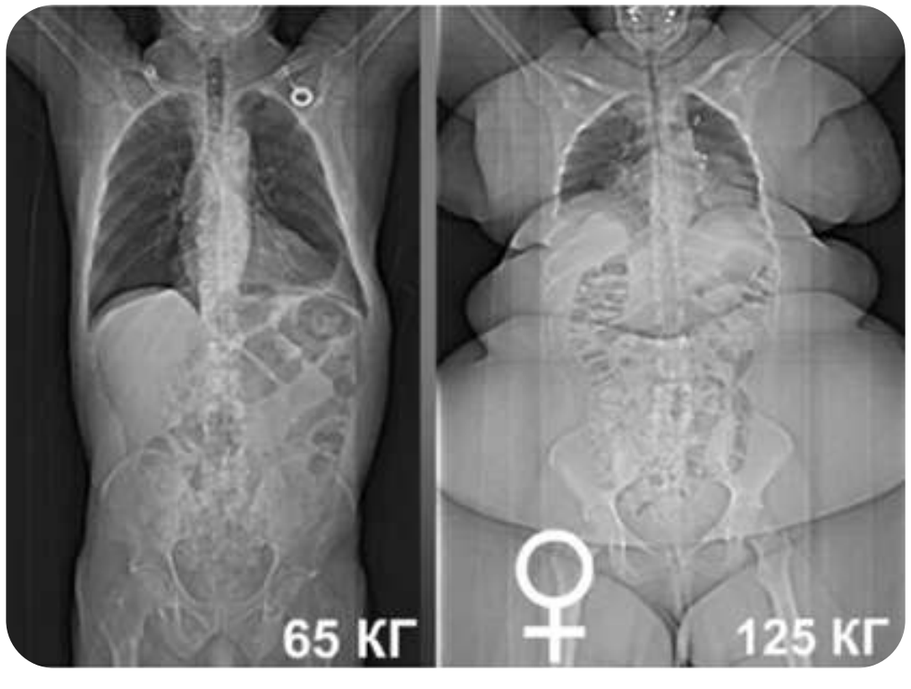
Сеченовский Университет

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Метаболический синдром в климактерическом периоде

- Значительная прибавка массы тела (5–10 кг) за короткий период времени (6–12 месяцев) с наступлением менопаузы
- Возрастает риск развития метаболического синдрома или ухудшается течение и прогноз уже существующего





Метаболический синдром и половая жизнь

- Атеросклероз, гипертония, метаболический синдром
- ↓ кровенаполнения влагалища и клитора
- Ухудшение лубрикации
- Дискомфорт при коитусе
- ↓ вагинальных ощущений
- Гипооргазмия/аноргазмия

Метаболический синдром снижает женскую сексуальность

- Установлена связь между ожирением и недержанием мочи
- Женщины с ИМТ > 30 кг/м2 имеют в 3,1 раз больше шансов развития недержания мочи по сравнению с женщинами, ИМТ которых составляет от 22–24 кг/м2
- Повышение ИМТ на каждые 5 кг/м2 увеличивает риск развития недержания мочи на 60%
- Модифицируемые факторы риска

Генитоуринальный синдром в менопаузе

- 1 линия терапии включает лубриканты при лёгкой вульвовагинальной атрофии
- Эстрогенотерапия — «золотой» стандарт лечения вульвовагинальной атрофии

Приоритет терапии генитоуринального синдрома в менопаузе

- Местная терапия эстрогенами в низких дозах предпочтительна для женщин с жалобами на сухость влагалища или связанным с этим дискомфортом при половой жизни

- Препараты антимускаринового действия в комбинации с локальными эстрогенами являются терапией первой линии женщин с синдромом императивных нарушений мочеиспускания и/или с ГМП

Соотношение пользы и риска МГТ?

Оптимальные подходы к лечению ожирения

- Рекомендуется всем пациенткам измерение окружности талии (ОТ), как ключевого показателя абдоминального/висцерального ожирения

Индекс массы тела рассчитывается по формуле:

$$I = \frac{m}{h^2},$$

где:

- m — масса тела в килограммах
- h — рост в метрах,

и измеряется в кг/м².

- Рекомендуется всем пациенткам определение массы тела, роста и вычисление индекса массы тела (ИМТ) для диагностики избыточной массы тела и ожирения

ИМТ < 18.5:	Ниже нормального веса
ИМТ >= 18.5 И < 25:	Нормальный вес
ИМТ >= 25 И < 30:	Избыточный вес
ИМТ >= 30 И < 35:	Ожирение I степени
ИМТ >= 35 И < 40:	Ожирение II степени
ИМТ >= 40:	Ожирение III степени

- В клинической практике применяется вычисление отношения окружности талии (ОТ) к окружности бёдер (ОБ).
При ОТ/ОБ > 0,8 — андроидное (абдоминальное), подкожно-абдоминальное и висцеральное ожирение.
При ОТ/ОБ < 0,7 ожирение называют гиноидным.

Лечение метаболических нарушений

1. Питание и диета
2. Менопаузальная гормональная терапия (МГТ)
3. Орлистат
4. Сибутрамин
5. Сибутрамин в комбинации с метформином
6. Лираглутид

- Ожирение и метаболический синдром в менопаузе встречаются в 3 раза чаще, чем в репродуктивном возрасте
- Ожирение в менопаузе увеличивает кардиологические, метаболические и онкологические риски (рак молочной железы)
- Снижение массы тела наряду с менопаузальной гормональной терапией, физической активностью и правильным питанием уменьшает риск сопутствующих ожирению заболеваний

Диета?

Фокус на пищу с достаточным содержанием нутриентов,
НО с низкой энергетической ёмкостью!

Как и чем заполнять желудок?

Проблемы различных диет

Все диеты рекомендуют приём большого количества пищевых волокон (20–30 г в сутки)

Проблема увеличения пищевых волокон в рационе:

- овощи и фрукты содержат дополнительные калории за счёт углеводов
- а отруби имеют плохие вкусовые качества и могут вызывать метеоризм и дискомфорт

Диета	Углеводы (%)	Белки (%)	Жиры (%)	Насыщенные жирные кислоты (%)	Моно-насыщенные жирные кислоты (%)	Поли-насыщенные жирные кислоты (%)	Холестерин (мг/день)	Пищевые волокна (г/день)
Американская диетическая ассоциация	55–65	15	20–30	<10	–	–	<300	20–30
Американская кардиологическая ассоциация	55–65	15	25–35	7–10	–	–	<300	25
Национальная образовательная программа США по холемтерину	55–65	15	30	<10	20	10	<300	20–30
Диета изменения стиля жижеи (TLC)	55–65	15	25–35	<7	20	10	<200	20–30
Диета при гипертонии (DASH)	55–65	15	25–35	<7	–	–	–	20–30
Американская диабетическая ассоциация	55–65	15	20–30	<7	–	–	<300	20–30
Средиземноморская диета	55–65	15	30	<10	15	5	200	20
Диета Weight Watchers	55–65	15	20–30	<10	–	–	<300	20–30

Негормональная терапия

Рекомендуется применение альтернативных негормональных методов лечения женщинам, имеющих противопоказания к МГТ или не желающих использовать МГТ для купирования климактерических расстройств

- **Клинический гипноз** снижает частоту и степень тяжести вазомоторных симптомов, улучшает сон и настроение
- **Акупунктура** является эффективным средством коррекции вазомоторных симптомов
- Лекарственные препараты цимицифуги кистевидной корневищ (экстракт)

Экстракт цимицифуги кистевидной

Все указанные механизмы и клинические эффекты определены в исследованиях только для Цимицифуги кистевидной, остальные виды Цимицифуги пока изучены недостаточно

- Обладает центральным серотонинергическим эффектом (содержат компоненты, связывающие серотониновые рецепторы 5Н)
- Имеются данные о возможности стимуляции неких веществ (эстрогенсвязывающие белки), опосредованно подавляющих или стимулирующих эстрогеновые рецепторы
- Существует гипотеза о возможном связывании с не a и и не b, ещё не идентифицированными подтипами эстрогенных рецепторов, тем самым исключая влияние на молочную железу и эндометрий

×

Сеченовский Университет

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Программа антивозраст, ANTI-AGE, эстетическая гинекология

В биологический возраст коррективы вносить можно

На сегодня имеется уникальный спектр медицинской помощи, направленной на восстановление женского здоровья, психоэмоционального состояния и качества жизни

- Технология применения лазерного воздействия на интимные зоны женщин
- Плазма, обогащённая тромбоцитами (PRP)
- Введение филлеров, антивозрастные препараты, в том числе на основе экстракта человеческой плаценты
- Методы радиочастотного воздействия и многие другие технологии

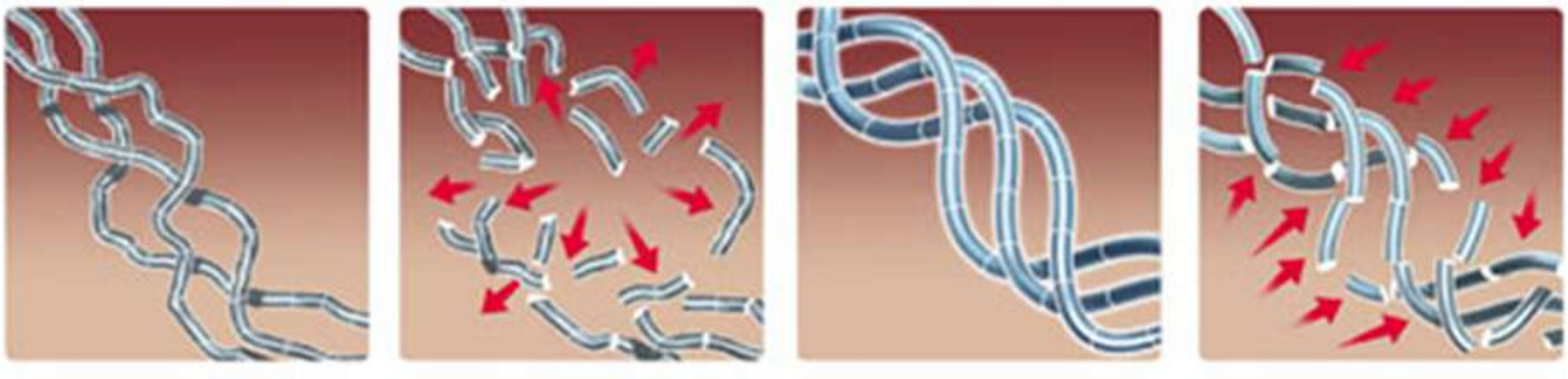
PRP в гинекологии

PRP — это плазма крови, концентрация тромбоцитов в которой более 1 млн.

- В α-гранулах тромбоцитов содержится около 30 факторов роста (ФР)
- За первые 10 минут тромбоциты вырабатывают около 70% ФР

Профилактика развития опущений, пролапсов и недержаний

Когда необходимо начинать помогать?



- До 30–35 лет ежегодно восстанавливается около 6 кг коллагена в коже
- После 35 — только 3 кг!

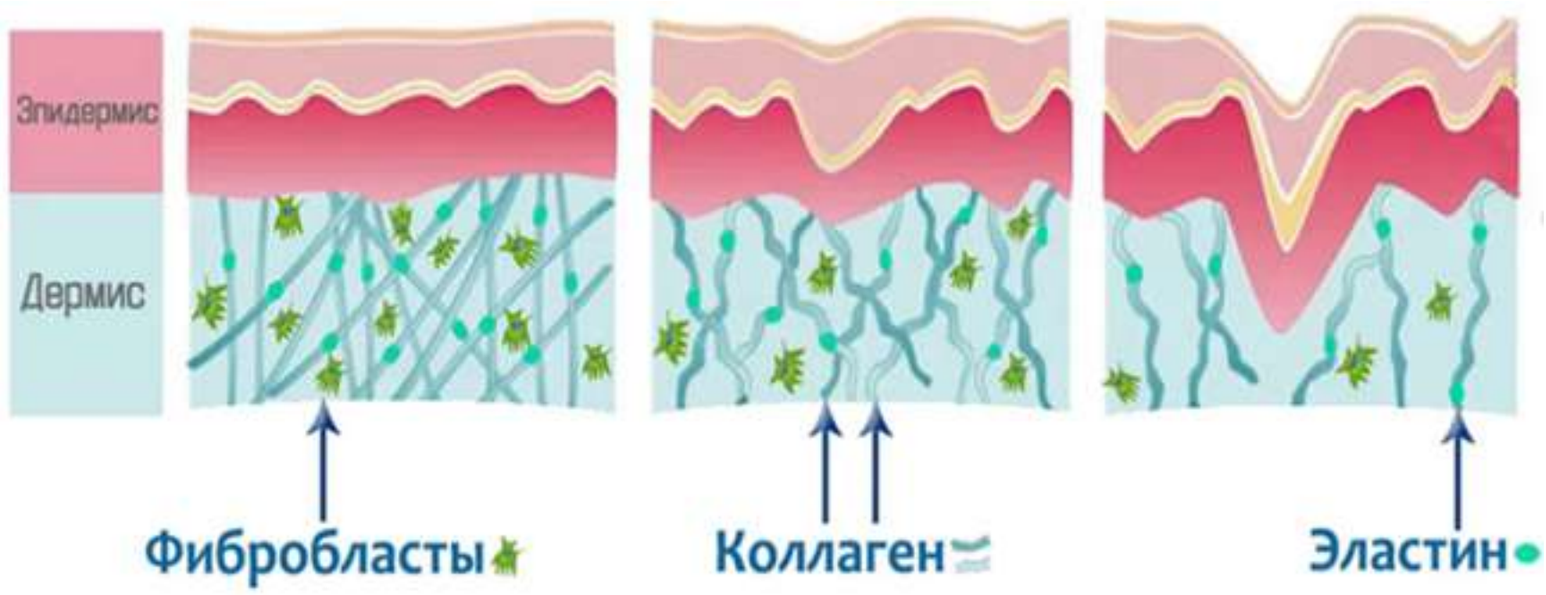
Вот почему необходимо начинать заботиться о себе уже после 25 лет

Как защитить себя от преждевременного старения

Неабляционный или абляционный лазер?

Неабляционный Er:YAG и Nd:YAG или абляционный CO_2

- Ремоделирование коллагена в субэпителиальной соединительной ткани/фасции
- Методики рассчитаны на этапную стимуляцию активности фибробластов, которая проводится за 2–4 процедуры, с интервалом в 30–45 дней



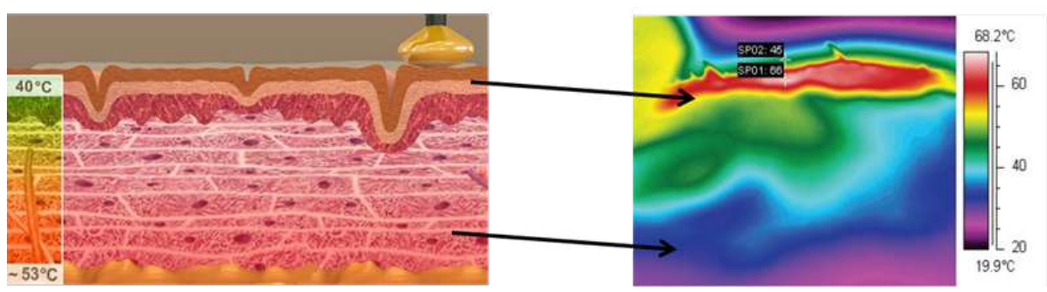
Эстетика наружных половых органов

Операция на половых губах в сочетании с иссечением кожи на входе во влагалище. Актуальна для уже рожавших женщин, у которых кожа промежности растянута или деформирована послеродовыми швами. Устранение этих кожных складок позволит придать этой зоне более аккуратный внешний вид

Контурная пластика больших половых губ. Введение гиалуроновой кислоты позволит восполнить объём тканей этой зоны, увеличить упругость кожи, скорректировать рельеф преддверия влагалища, прикрыть небольшое выступание одной малой губы

Худэктомия или иссечение капюшона клитора. Устранение складок кожи вокруг и по бокам головки клитора в сочетании с одно- или двусторонней пластической операцией половых губ сделает интимное место более аккуратным и привлекательным, откроет новые ощущения

RF лифтинг



- Энергия радиоволны при прохождении через ткани преобразуется в тепло
- Кожа нагревается до температуры разрушения белков; волокна коллагена, составляющего «каркас» кожи, сжимаются; кожа уплотняется
- Визуально кожа наружных половых органов подтягивается, исчезает обвислость, чётче прорисовываются контуры
- Повреждение коллагена запускает естественный процесс синтеза нового коллагена, который постепенно замещает разрушенный

Пессарии

Виды гинекологических пессариев

- Маточные (чашечные)
- Уретральные
- Кубические
- Маточные кольца (кольцевые)

Показания для введения пессариев

- Пролапс гениталий, когда необходимо отсрочить время операции
- Женщины старшей возрастной группы с сопутствующими заболеваниями
- Стрессовое недержание мочи
- Отказ от хирургической коррекции

Озоно-, кислородо-, физио- и карбокситерапия

1. ГУСМ
2. Склероатрофический лишай
3. Локальные жировые отложения
4. Дряблость кожи наружных половых органов

Карбокситерапия в лечении возрастных изменений

Механизмы

- **биохимические** — при избытке CO_2 в зоне введения происходит снижение pH среды
- **рефлекторно-химические** — соединяясь с водой, CO_2 образует угольную кислоту, которая возбуждает хеморецепторы рефлексогенных зон
- **рефлекторно-механические** — инъекционное введение CO_2 локально раздражает определённые афферентные зоны

Липотрансфер и липофилинг в гинекологии

- **Фэтграфтинг**
- **Графты** — частицы, «капельки» жира
- **Макро, микро, наножир**

Перинеовагинальный лифтинг

— малоинвазивная хирургическая процедура для стяжения и соединения повреждённых мышц промежности с применением специальных нитей

По мере биодеградации материал нитей замещается волокнами коллагена и образуется своеобразный каркас, поддерживающий ткани изнутри, что позволяет достигнутому эффекту сохраняться на протяжении до 3х лет

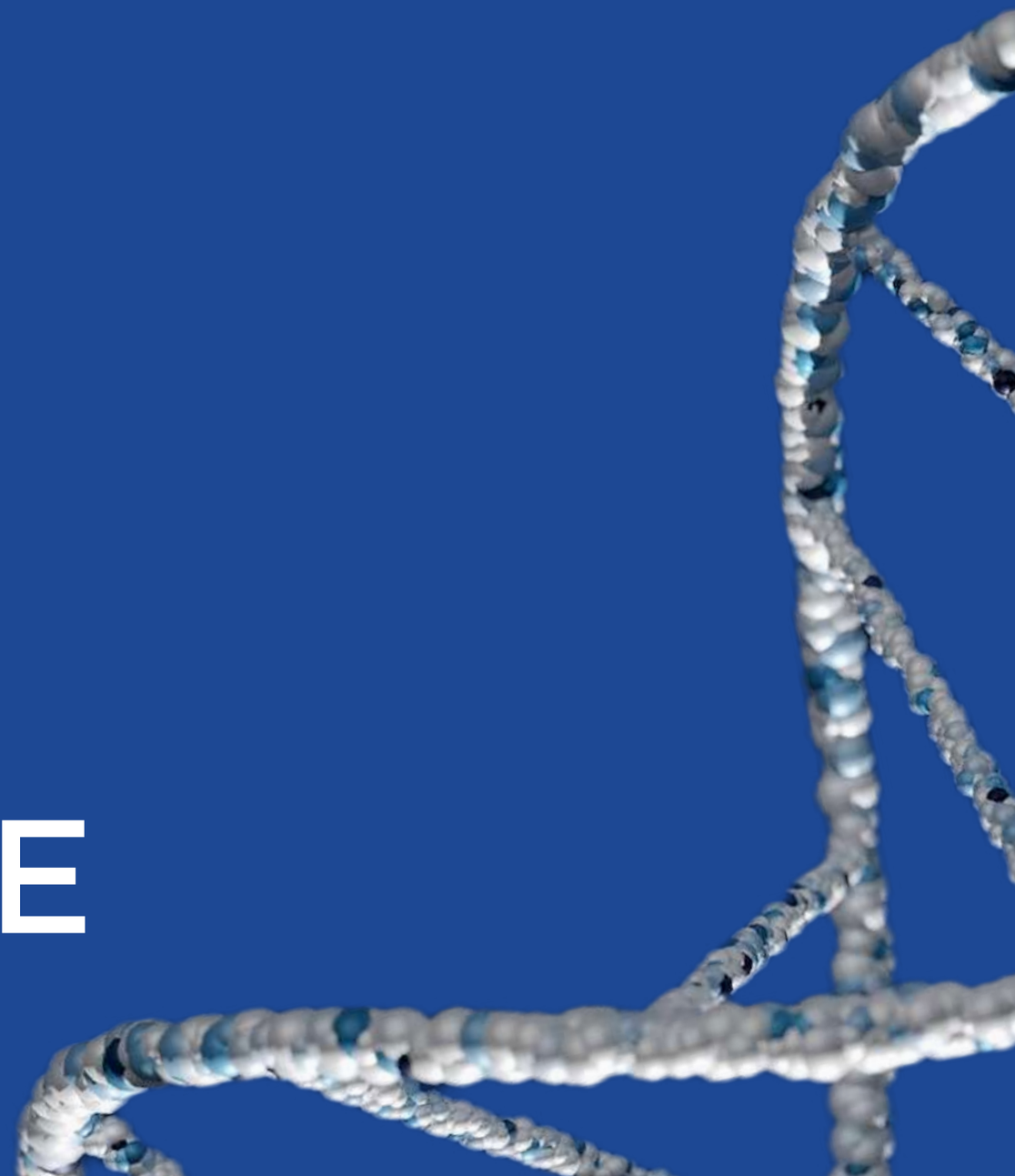
Результаты можно оценить сразу же после процедуры

- Мышцы промежности подтягиваются
- Вход во влагалище сужается
- Внешний вид гениталий становится более эстетичным
- Деликатные проблемы в виде недержания мочи и газов уходят

Нормализуется биоценоз влагалища, поэтому ощущения во время полового акта приобретают яркость и насыщенность, оргазм достигается легче

Показания для перинеовагинального лифтинга

- Синдром растянутого влагалища с зиянием половой щели
- Рубцовые изменения после разреза промежности
- Ухудшение качества сексуальной жизни
- Хронический дисбиоз влагалища
- Частые вульвовагиниты и другие патологические процессы
- Опущение половых органов с запорами, недержанием газов
- Ранние признаки недержания мочи

Сеченовский Университет

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ